

- 123☆☆☆
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息はプロスタグランジン合成酵素である COX-1 阻害作用をもつ NSAIDs の使用によって、システニルロイコトリエンが過剰産生され、鼻症状および気道狭窄症状を呈する。
- 124☆☆☆
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息患者の気道では好塩基球炎症が強くみられる。
- 125☆☆☆
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息は IgE 抗体を介したアレルギーの機序で発症する。
- 126☆☆☆
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息は成人喘息の 5~10% を占め、男女比は 2:1 で男性に多い。
- 127☆☆☆
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息の好発年齢は 60~80 歳代である。
- 128☆☆☆
☑☑☑ NSAIDs 過敏喘息は皮膚テストやアレルギー学的検査で診断可能である。
- 129☆☆☆
☑☑☑ 妊娠中は、喘息治療を一時中止する。
- 130☆☆☆
☑☑☑ 妊娠中の喘息治療の第一選択は吸入ステロイドである。
- 131☆☆☆
☑☑☑ 妊娠初期に喘息が悪化することが多い。
- 132☆☆☆
☑☑☑ ロイコトリエン受容体拮抗薬 (LTRA)、長時間作用性抗コリン薬 (LAMA) の妊娠に対する安全性は確立されていない。
- 133☆☆☆
☑☑☑ 周術期管理では、FEV1 を予測値あるいは自己最良値の 80% 以上まで改善させておくべきである。
- 134☆☆☆
☑☑☑ 周術期管理として、喘息発症後の NSAIDs 使用歴、ラテックスアレルギーの有無を確認しておく。
- 135☆☆☆
☑☑☑ 喘息では上気道アレルギー性炎症を合併することが多い。
- 136☆☆☆
☑☑☑ 喘息では好中球性炎症が主体の慢性副鼻腔炎を合併しやすい。
- 137☆☆☆
☑☑☑ 肥満は喘息を軽快させる。
- 138☆☆☆
☑☑☑ ストレス、不安、抑うつは喘息の悪化、難治化に影響する因子である。